

"STREP AGALACTIAE"

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

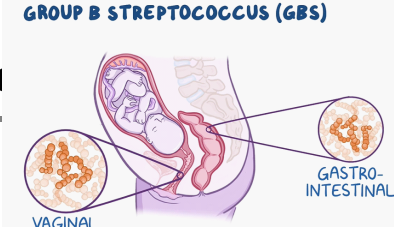
- ROUND-SHAPE
- NO MILK
- HUMAN PATHOGEN RESPONSIBLE for INFECTIONS (COMMONLY in PREGNANT WOMEN & NEWBORNS)
- ROUND BACTERIA that GROW in CHAINS
- PREVIOUSLY KNOWN to INFECT CATTLE
- ↓ MILK PRODUCTION
- called GROUP B STREP (GBS) (LANCIEFIELD CLASSIFICATION)
- DEVELOPED by REBECCA LANCEFIELD

STREP AGALACTIAE

- VERY COMMON
- 20% of HEALTHY ADULTS are COLONIZED
- PROBLEMS ARISE in:
 - NEWBORNS
 - PREGNANT WOMEN
 - ADULTS w/ UNDERLYING DISEASE
 - DIABETES MELLITUS or PREGNANCY
 - PREEXISTING INFECTION
 - eg HIV
- SPLEEN - IMPORTANT for IMMUNITY AGAINST ENCAPSULATED BACTERIA
- INFECTIONS are MORE COMMON with:
 - Splenectomy
 - FUNCTIONAL ASPLenia
 - SICKLE CELL DISEASE

Gynéco-obstétrique

STREPTOCOQUE B ET GROSSESSE



I. Introduction - définition

- Principal agent responsable des infections bactériennes néonatales.
- Le portage vaginal maternel est fréquent et le plus souvent asymptomatique.

Ne pas confondre streptocoque A et streptocoque B !!!

- Le portage maternel asymptomatique du streptocoque B est fréquent pendant la grossesse et fait surtout craindre une possible infection néonatale sans réel danger pour la mère.
- L'infection maternelle à streptocoque A est exceptionnelle. Cependant, elle est particulièrement redoutée du fait de sa gravité : elle peut entraîner le décès maternel par choc avec défaillance multiviscérale (syndrome de choc toxique streptococcique).

II. Epidémiologie

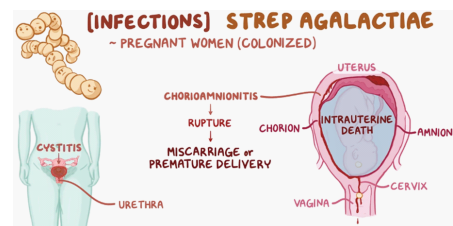
- 5 à 30% des femmes sont colonisées pendant la grossesse.
- Le portage est transitoire, intermittent ou chronique.

Risque :

- Accouchement prématuré (x 1,5).
- Infections néonatales sévères (IFM) (mortalité 6%).
- Endométrite post-partum (20%).

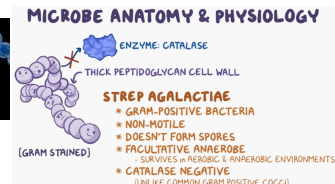
Facteurs de risque :

- Portage maternel de SGB.
- Ouverture prolongée de la poche des eaux (> 18h).
- Fièvre maternelles en début de travail (> 38°C) : au cours du travail, on peut avoir un état de fébricule ne dépassant pas 38°C -> si T° > 38°C : penser à une infection.
- Prématurité spontanée avant 35 SA (le dépistage n'est pas encore réalisé -> si portage présent : risque accru d'infection grave).



III. Pouvoir pathogène et transmission materno-fœtal :

- Streptococcus agalactiae (principal représentant du SGB), cocci gram positif.
- Les souches virulentes sont retrouvées majoritairement parmi les sérotypes I et III.
- Le risque de transmission materno-fœtale est lié :
 - Au sérotype en cause.
 - A la densité de la colonisation maternelle.
- Trois modes de contamination du nouveau-né :
 - Voie hématogène placentaire (responsable d'infection congénitale) rare.
 - Voie ascendante (RPM).
 - Contamination lors du passage de la filière génitale.



IV. Diagnostic positif ← QE!!

- Dépistage doit être réalisé entre 34 SA et 38 SA.
- Le prélèvement pour le dépistage du Streptocoque B est réalisé à l'écouvillon -> écouvillonnage endocervical et exocervical : il doit se faire sur l'ensemble de la cavité vaginale incluant le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve.

Chez la mère :

- Grossesse : chorio-amnionite → douleur à la mobilisation de l'utérus, tachycardie maternelle, tachycardie fœtales, LA louche et infecté → extraction fœtale en urgence : césarienne (protégé l'abdomen : risque de péritonite) ou VB si accouchement imminent.
- Post-partum : endométrite → dans les 3 – 5 premiers jrs du post-partum, se caractérise par : douleur, fièvre, lochies fétides +++ et utérus mal involué (restant de grande taille).

Si la fièvre maternelle > 38° isolée
> A l'association d'une fièvre + 2 des critères suivants :

- HyperGB maternelle > 15 g/l
- Tachycardie maternelle > 100 bpm
- Tachycardie fœtale > 160 bpm
- Douleur à la palpation utérine
- Odeur malodorante du liquide amniotique

Chez le nouveau-né :

❖ Critères anamnestiques de suspicion d'infection néonatale :

- Fièvre maternelle per-partum.
- RPM avant le travail.

⇒ Ouverture prolongée de l'œuf.

- ⇒ Chorio-amnionite
- ⇒ Portage vaginal SGB

❖ Signes cliniques d'infection néonatale :

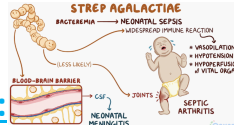
- ⇒ Fièvre $\geq 38^\circ$ ou hypothermie $< 35,5^\circ$.
- ⇒ Signes hémodynamiques : hypotension artérielle, bradycardie.
- ⇒ Signes respiratoires : tachypnée, détresse respiratoire.
- ⇒ Signes neurologiques : troubles conscience, convulsion.
- ⇒ Signes cutanés : purpura, éruption.

❖ Biologie : chez le nouveau-né :

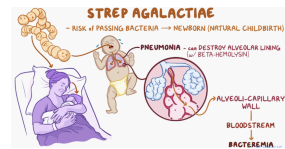
- ⇒ NFS hyperleucocytose, CRP augmenté, pro-calcitonine.
- ⇒ Prélèvements bactériologiques : placentaire, gastrique, bouche, nez, oreilles, sang fœtal.
- ⇒ Démarrer l'ATB probabiliste (visant SGB) puis adapter selon les résultats de l'antibiogramme.

V. Conséquences fœtales et néonatales

- Septicémie, Choc septique.
- Méningite.



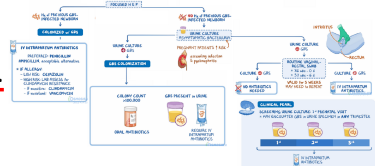
- Pneumopathie.
- Infection urinaire.



VI. Prise en charge thérapeutique :

• Au cours de la grossesse : ➔ Plv vaginal quel que soit l'âge de la grossesse si :

- Prurit ou des leucorrhées vulvaires.
- MAP (dont la 1ère étiologie est l'infection maternelle -> plv vaginal + ECBU).
- RPM (-> risque de chorio-amnionite).



• Dépistage doit être réalisé systématiquement entre 34 SA et 38 SA.

- ⇒ Le dépistage systématique est inutile chez les femmes ayant un antécédent d'infection materno-fœtale à streptocoque B ou ayant présenté au cours de la grossesse une bactériurie à streptocoque B, car chez elles, l'antibioprophylaxie per-partum sera systématique.
- ⇒ Le portage du Streptocoque B ne comporte aucun risque pour le fœtus tant que les membranes sont intactes.
- ⇒ C'est pour cette raison qu'on ne traite qu'en per-partum ou en cas de rupture prématurée des membranes.
- ⇒ Il n'y a pas d'intérêt à traiter systématiquement une femme porteuse d'un Streptocoque B au cours de la Grss

✚ Si RPM avant 37 SA :

- ❖ Antibioprophylaxie par amoxicilline (1 g/8h IV).
- ❖ Si la culture du prélèvement cervico-vaginal est négative : arrêt du traitement.
- ❖ Si elle est positive : antibiothérapie poursuivie 5 jours.



✚ Possibilité d'utiliser : pénicilline G ou ampicilline.

✚ En cours de travail : Chez des patientes ayant un antécédent de pathologie périnatale à SB ou de portage à SB identifié ➔ Antibioprophylaxie le plus tôt possible au cours du travail : 2g d'amoxicilline puis 1 g/4h IV jusqu'à l'accouchement.

✚ En cas d'allergie à la pénicilline : un antibiogramme est justifié en raison de la résistance de certaines souches de SGB aux macrolides : les alternatives sont :

- ❖ Céfotaxime : 1 g/8h.
- ❖ Erythromycine : 500 mg/6h per os jusqu'à l'accouchement.
- ❖ Clindamycine : 900 mg/8h.



VII. Prévention :

- Dépistage systématique du streptocoque B
- Antibio-prophylaxie per-partum en cas de :

- Diagnostic du portage de SGB en fin de grossesse
- Bactériurie à SGB au cours de la grossesse
- ATCD d'infection néo-natale à SGB
- Absence de prélèvement vaginal de dépistage du SGB avec accouchement avant 37SA, RPM > 12h, Température $> 38^\circ$ au cours du travail

